



סכמת מציל

טיפול בפצוע ברמת לוחם ללא הכשרה רפואית



מבוא

• טראומה – פגיעה במערכות הגוף ע"י גורם חיצוני

• מערכות הגוף:

• מע' הנשימה

• מע' לב וכלי דם

• מע' שריר-שלד

• מע' עור

• מע' העצבים

• ועוד





שלושת מתארי הטיפול ב TCCC

- גישה לפצוע בעת לחימה שונה במתארים השונים:
- **מתאר "תחת אש"**
- "עליונות אש היא התרופה הטובה ביותר"
- "חיי הפצוע הראשון מונחים בידי הראשון שמניח את התחבושת"
- **מתאר "מאויים-מאובטח"**
- **מתאר "הפינוי הטקטי"**





גישה לפצוע במתאר "תחת אש"

- השב אש
- פעל על מנת למנוע פציעות נוספות (פצוע וכוח)
- צפה מהפצוע לתפוס מחסה ולטפל בעצמו
- במידה ולא מצליח לבדו:
 - הנחה את הפצוע לעשות זאת
 - באישור מפקד הכוח בלבד – סייע לפצוע לעשות זאת
- הטיפול הרפואי תחת אש הוא:
 - השגת עליונות אש ונטרול איום
 - מניעת פציעות נוספות (כולל איסוף הנשק וגרירה)
 - הנחת CAT
 - קידום הפצוע למתאר "מאויס מאובטח"



גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"





גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"

- לסכמת מציל יש סדר הגיוני:

- בטיחות קודם כל

- החלטה על מקום טיפול "נוח"

- אבטחת המקום

- תגבור בכוח אדם נדרש (רפואי ולא)

- עצירת דימומים מסכני חיים בולטים לעין

- נתיב אוויר

- נשימה

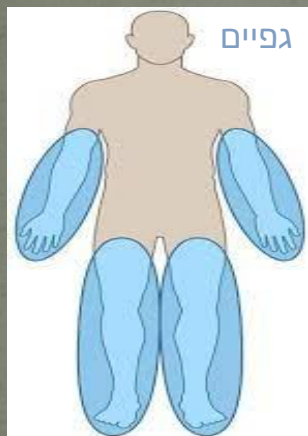
- חיפוש אחר דימומים נוספים וכיסוי

- פינוי והשגחה

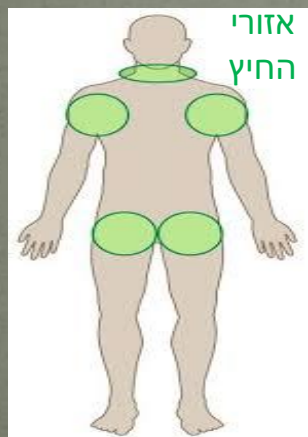




גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"



גפיים



אזורי
החיץ

• בטיחות

• אבטחה והרחקה מגורם מסכן

- אם הלוחם איבד כושר לחימה, נצירת הנשק ואיסופו

• עצירת דימומים מסכני חיים מגפיים ואזורי חיץ ותיעוד שעת הנחה

- יש לשקול צורך בביצוע נקודות לחיצה או לחץ ישיר כאשר לא ניתן להניח CAT

• דיווח ראשוני ודרישות לפינוי:

- מקום
- מה קרה
- מתי קרה
- מספר פצועים
- מצב פצועים

5 המ'

פינוי והשגחה

דימומים נוספים

נשימה

נתיב אוויר

בטיחות



גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"

• נתיב אוויר

• בדיקת הכרה באמצעות קול וגירוי כאב – פעם אחת בלבד

• תוצאות אפשריות:

• בהכרה מלאה

• מעורפל הכרה

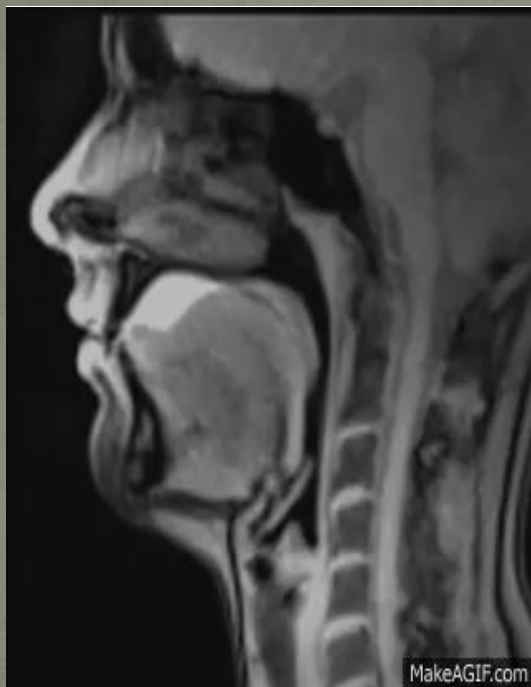
• מחוסר הכרה

• סריקת חלל הפה

• במידה ויש הפרשות – סלק הפרשות ע"י

הטיה של הגוף כולו

• הסר קסדה



פינוי והשגחה

דימומים נוספים

נשימה

נתיב אוויר

בטיחות



גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"

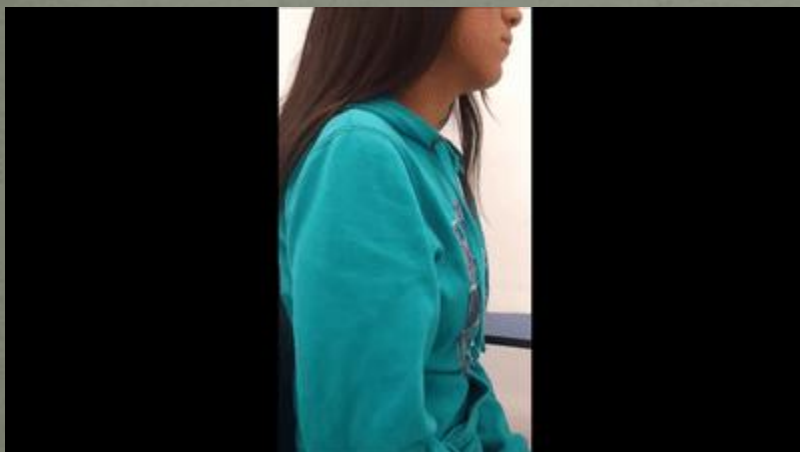
נשימה

הערכת נשימה במשך 10 שניות

השאלות שנשאלות:

"נושם או לא נושם?"

"האם נושם רגיל?"



פינוי והשגחה

דימומים נוספים

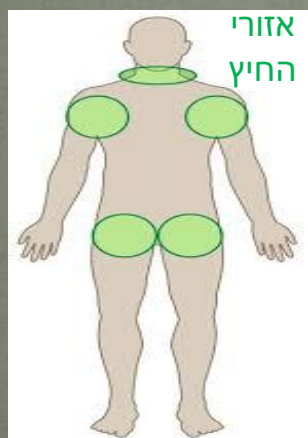
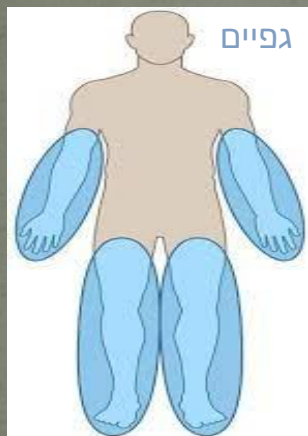
נשימה

נתיב אוויר

בטיחות



גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"



• דימומים נוספים:

- במידה וניתן – הפשטה מלאה לצורך חיפוש אחר פציעות נוספות
- סקירת דימומים על ידי סחיטה מלאה של הגפיים, ואזורי החיץ
- עצירת דימומים שהתגלו:
- בעדיפות ע"י לחץ ישיר באמצעות FirstCare/ת"א רגיל

• כיסוי:

- נפגע נייד: נעלים, אפוד קרמי + קסדה. שמיכת מילוט
- נפגע שוכב: שמיכת מילוט (סוכריה) ואפוד קרמי פרוס + קסדה
- דיווח דנ"ה: דימומים, נשימה, הכרה

פינוי והשגחה

דימומים נוספים

נשימה

נתיב אוויר

בטיחות



גישה לפצוע במתאר "מאויים-מאובטח"



• השגחה:

- בפצוע בהכרה: שמירה על תקשורת
- מעורפל הכרה או ללא הכרה: שמירה על נתיב אוויר
- סילוק הפרשות ואז מצח סנטר
- תנוחת שכיבה יציבה
- ניתור אחר התחדשות דימום
- מתחת ל CAT שהונח
- תחבושת ספוגה דם

• פינוי:

- דרך ניוז מומלצת לנפגע שוכב היא אלונקה, אופציה ב' סחיבה בשלושה/זוג
- אין להתעקש להשכיב מטופל שמתנגד לשכב
- ניטור פצוע במהלך הפינוי לפי דנ"ה

פינוי והשגחה

דימומים נוספים

נשימה

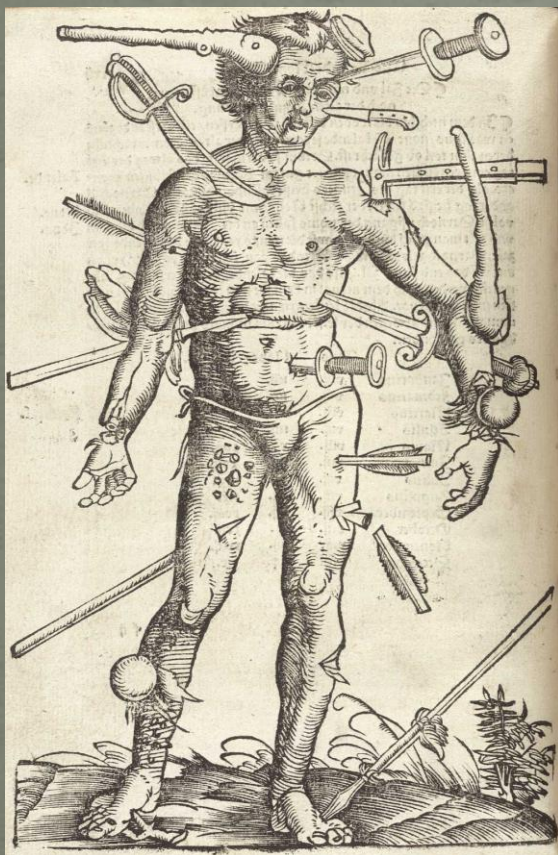
נתיב אוויר

בטיחות



דגשים

• העבר דיווח מסודר בהשלמת הסכמה עבור כל אחד מהפצועים:



• מנגנון פציעה

• הכרה

• נשימה

• טיפול שבוצע

• מוכנות לפינוי

• סריקות ותיק חפצים

• "אלונקות באוויר"

פינוי והשגחה

דימומים נוספים

נשימה

נתיב אוויר

בטיחות



סכמה באירוע רב נפגעים

- ברגע שהמפקד הרפואי יתפנה, הוא יחד עם מנהל האירוע יתחיל את הטריאז'
- מטרת החובשים והמח"צים בנאפ"ל – הצלת חיים והכנת הפצוע לטריאז' ע"י המנהל הרפואי
- הפעולות בהן ינקטו המטפלים הן ע"פ **סכמת מח"צים**
 - החובשים יעשו סכמת מח"צים, ובמידת הצורך פקינג
 - **לא יוחדר מנתב אוויר, לא יספרו נשימות, לא יימדד דופק בשלב הזה.**
 - בסיום סכמת מח"צ על פצוע, **יש לעבור לפצוע הבא!**
 - כל מטופל עם מצוקה נשימתית יקבל שיפור תנוחה:
 - שכיבה יציבה או הושבה

שאלות?





בטיחות	אבטחה והרחקה מגורם מסכן אם הלוחם איבד כושר לחימה נצירת הנשק והסרתו עצירת דימומים מסכני חיים ורישום שעת ההנחה - יש לשקול צורך בביצוע נקודת לחיצה או לחץ ישיר דיווח ראשוני ודרישה לפינוי (5 המ' – מקום, מה קרה, מתי קרה, מספר פצועים, מצב פצועים)
נתיב אוויר	בדיקת הכרה באמצעות קול וגירוי כאב (פעם אחת בלבד): בהכרה/מעורפל הכרה/מחוסר הכרה סריקת חלל הפה - במידה ויש הפרשות סילוק הפרשות באמצעות הטיה של הגוף כולו הסרת קסדה
נשימה	הערכת נשימה 10 שניות (השאלה שנשאלת "נושם או לא נושם") - בנוסף שאל את עצמך "האם הוא נושם תקין?"
דימומים נוספים	במידת הניתן הפשטה מלאה לצורך חיפוש אחר פציעות נוספות סריקת דימומים על ידי סחיטה מלאה של הגפות (זרועות ורגליים), דגש על אזורי חיץ עצירת דימומים חמורים שהתגלו - בעדיפות ללחץ ישיר (ת"א/FirstCare) כיסוי: - נפגע נייד: נעליים, אפוד קרמי + קסדה. שמיכת מילוט ככל שמתאפשר - נפגע שוכב: שמיכת מילוט (סוכריה) ואפוד קרמי פרוס + קסדה על גבי אלונקה דיווח דנ"ה: - דימום - נשימה - הכרה
פינוי והשגחה	השגחה: - בהכרה: שמירה על תקשורת - מעורפל הכרה או ללא בהכרה: שמירה על נתיב אוויר פתוח (תנוחת שכיבה יציבה) - ניתור התחדשות דימום מתחת ל CAT שהונח - ניתור התחדשות דימום בתחבושת (תחבושת ספוגה בדם) פינוי: - דרך מומלצת לנפגע שוכב היא אלונקה, אופציה ב' סחיבה בשלושה - אין להתעקש להשכיב מטופל שמתנגד לשכב